

3.14 Nicht-melanotischer Hautkrebs

Tabelle 3.14.1
Übersicht über die wichtigsten epidemiologischen Maßzahlen für Deutschland, ICD-10 C44

Inzidenz	2021		2022		2023	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer
Neuerkrankungen	111.030	125.640	115.490	127.940	116.610	126.210
rohe Neuerkrankungsrate ¹	263,4	306,1	273,8	312,1	276,0	307,5
standardisierte Neuerkrankungsrate ^{1, 2}	139,0	173,7	142,8	175,8	143,8	172,7
mittleres Erkrankungsalter ³	74	76	74	76	74	76
Mortalität	2021		2022		2023	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer
Sterbefälle	464	714	521	754	541	791
rohe Sterberate ¹	1,1	1,7	1,2	1,9	1,3	1,9
standardisierte Sterberate ^{1, 2}	0,3	0,8	0,4	0,9	0,4	0,9
mittleres Sterbealter ³	88	84	88	84	88	85
Überlebensraten	5 Jahre		10 Jahre		25 Jahre	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer
absolute Überlebensrate (2021 – 2023) ⁴	84	77	67	56		
relative Überlebensrate (2021 – 2023) ⁴	103	103	107	107		

¹ je 100.000 Personen ² altersstandardisiert nach alter Europabevölkerung ³ Median ⁴ in Prozent

Epidemiologie

Knapp drei Viertel der nicht-melanotischen Hautkrebsformen (heller Hautkrebs) sind Basalzellkarzinome (Basaliome). Diese metastasieren nur in Ausnahmefällen, vor allem bei geschwächter Immunabwehr, und verlaufen daher auch selten lebensbedrohlich. Sie können allerdings in das umgebende Gewebe, z. B. in den Knochen, einwachsen und dadurch zu erheblichen Einschränkungen der Lebensqualität führen. Etwa ein Viertel der Fälle sind Plattenepithelkarzinome, die vor allem ältere Personen betreffen. Jeweils rund zwei Drittel dieser Tumoren treten am Kopf oder Hals auf. Zu den seltenen Formen gehört u. a. das zu den neuroendokrinen Karzinomen zählende Merkelzell-Karzinom mit vergleichsweise ungünstiger Prognose sowie Adenokarzinome, die u. a. die Talg- und Schweißdrüsen betreffen. In 2023 sind in Deutschland geschätzt knapp 243.000 Personen erstmalig an nicht-melanotischem Hautkrebs erkrankt, dem stehen 1.332 Sterbefälle gegenüber. Nach Einführung des Hautkrebscreenings Mitte 2008 stieg die Inzidenz deutlich an, seitdem ist bei leicht schwankenden Raten keine eindeutige Tendenz erkennbar. Die Sterberaten sind, wenn auch auf sehr niedrigem Niveau, in den letzten zwei Jahrzehnten leicht gestiegen.

Risikofaktoren

Heller Hautkrebs tritt bei Menschen mit hellem Hauttyp häufiger auf als bei Menschen mit dunklerem Hauttyp. Der wichtigste Risikofaktor für hellen Hautkrebs ist eine starke Belastung der Haut mit ultravioletten (UV-)Strahlen. Dabei ist es egal, ob diese von der Sonne, aus dem Solarium oder anderen künstlichen UV-Quellen kommt. Das Risiko für ein Plattenepithelkarzinom steigt mit der kumulativen (lebenslangen) UV-Dosis. Beim Basalzellkarzinom wird das Risiko vermutlich zusätzlich auch durch die intermittierende (wiederkehrende intensive) UV-Belastung erhöht.

Wer schon einmal an hellem Hautkrebs erkrankt war, hat ein erhöhtes Risiko, nochmals daran zu erkranken. Aktinische Keratosen erhöhen das Risiko für ein Plattenepithelkarzinom. Entstehen kann heller Hautkrebs außerdem beispielsweise nach langjähriger Arsenbelastung, auf strahlengeschädigter Haut (zum Beispiel nach einer Strahlentherapie) oder unter einer immunsuppressiven Therapie, beispielsweise nach einer Organtransplantation.

Das gesetzliche Krebsfrüherkennungsprogramm sieht für Frauen und Männer ab dem Alter von 35 Jahren alle zwei Jahre eine Hautuntersuchung durch eine Ärztin oder einen Arzt (u. a. Dermatologe oder Hausarzt mit entsprechender Fortbildung) vor.

Abbildung 3.14.1

Altersstandardisierte Neuerkrankungs- und Sterberaten nach Geschlecht, ICD-10 C44, Deutschland 2006 – 2023
je 100.000 (alter Europastandard)

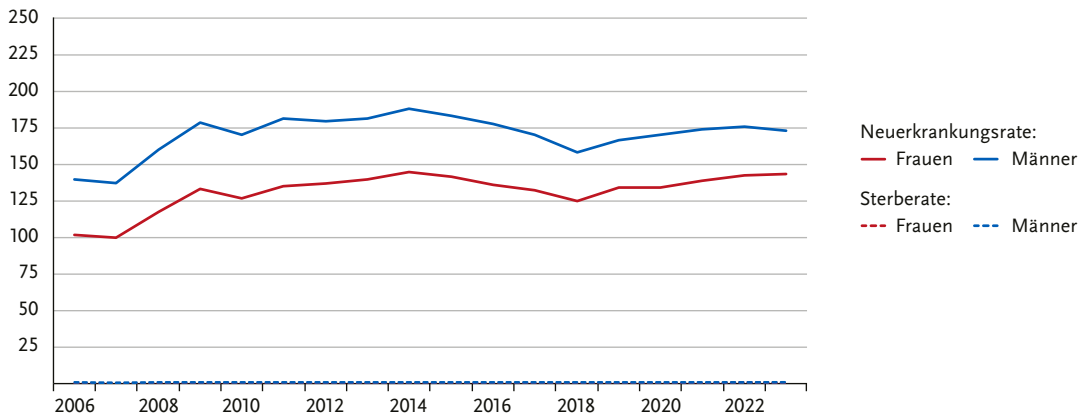


Tabelle 3.14.2

Verteilung der häufigsten nicht-melanotischen Hautkrebsformen nach Körperregion und Geschlecht, ICD-10 C44, Deutschland 2021 – 2023 (Anteile in %)

	Basaliome		Plattenepithelkarzinome	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
Kopf und Hals	60	60	60	72
Rumpf	20	21	10	7
obere Extremitäten	8	10	17	12
untere Extremitäten	7	5	10	4
überlappend/ohne nähere Angaben	4	4	4	4

Abbildung 3.14.2

Relatives 5-jahres-Überleben nach Histologie und Geschlecht, ICD-10 C44, Deutschland 2021 – 2023

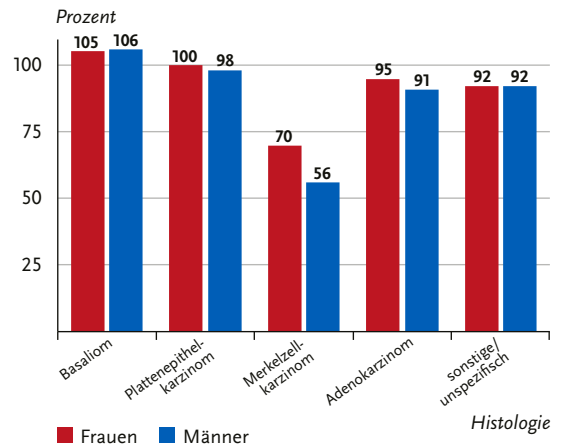


Abbildung 3.14.3

Altersspezifische Neuerkrankungsraten nach Geschlecht, ICD-10 C44, Deutschland 2021 – 2023
je 100.000

